Azienda Sanitaria Universitaria di Collebruno
Presidio Pediatrico Sant'Eufemia
S.C. Neuropsichiatria Infantile
Ambulatorio Epilessie dell'età evolutiva

Via dei Cipressi 9
34137 Trieste
Segreteria 040 3992400
Fax 040 3992418

Alla c.a. Dott.ssa Paola Cosatti
Pediatra di Libera Scelta
Tavagnacco - fax 0432 508877

REFERTO DI VISITA NEUROPSICHIATRICA INFANTILE

con registrazione EEG in veglia e iperpnea

DATI DEL PAZIENTE

Cognome:	**Furlan**	Nome:	**Tommaso**
Data di nascita:	**11/03/2015**	C.F.:	**FRLTMS15C11L483F**
Residenza:	**Tavagnacco**	Accompagnato da:	**Elisa Kosovel (madre)**

Data visita: 21/05/2024 N. referto: NPI-24-002871 Impegnativa: 0600A4417820193

MOTIVO DELLA CONSULENZA

Il piccolo Tommaso, aa. 9, viene condotto dalla madre per episodi di sospensione del contatto della durata di pochi secondi, plurimi nell'arco della giornata, notati dalle insegnanti della Scuola Primaria Borgo dei Gelsi di Tavagnacco a partire da marzo 2024. Durante gli episodi il bambino interrompe l'attività, fissa lo sguardo e talvolta presenta ammiccamento palpebrale; non cadute a terra, non perdita di urine.

ANAMNESI

Nato a termine da parto eutocico, peso alla nascita 3.280 g. Sviluppo psicomotorio nella norma. Convulsioni febbrili semplici a 2 anni (episodio singolo). Familiarità: lo zio paterno, sig. Mauro Furlan, ha presentato crisi di assenza in età scolare, risolte in adolescenza. Il padre, Andrea Furlan, riferisce cefalea emicranica. Non allergie note. Nessuna terapia in atto.

ESAME OBIETTIVO NEUROLOGICO

Peso 29 kg, altezza 133 cm. Vigile, collaborante, eloquio adeguato all'età. Nervi cranici indenni. Forza, tono e trofismo conservati e simmetrici. ROT normoevocabili. Coordinazione e marcia nella norma. Prova di iperpnea in ambulatorio: dopo circa 90 secondi comparsa di episodio di arresto psicomotorio con fissità dello sguardo di circa 8 secondi, con ripresa immediata.

EEG IN VEGLIA (REGISTRAZIONE N. EEG-24-1187)

Fase	Reperto	Durata
Veglia a riposo	attività di fondo alfa 9 Hz, ben organizzata e reattiva	12 min
Stimolazione luminosa	assenza di risposte fotoparossistiche	4 min
Iperpnea (3 min)	scarica generalizzata di complessi punta-onda a 3 Hz, sincrona e simmetrica, con correlato clinico di assenza	3 min

Registrazione eseguita dal tecnico di neurofisiopatologia Giulia Marussi e refertata dal Dott. Luca Bressan (S.C. Neurofisiopatologia) in data 21 maggio 2024.

CONCLUSIONI

Quadro clinico ed elettroencefalografico compatibile con **epilessia con assenze dell'infanzia (CAE)**. Si propone di iniziare terapia con etosuccimide sciroppo 250 mg/5 mL, 5 mL la sera per una settimana, poi 5 mL due volte al giorno; dose da adeguare al controllo clinico. Eseguire prima dell'avvio emocromo e funzionalità epatica.

Documento trasmesso via fax al Pediatra di Libera Scelta su richiesta della famiglia. Contiene dati sanitari riservati.
Se ricevuto per errore distruggerlo e darne comunicazione al mittente.

Indicazioni per la famiglia e la scuola

Sono state fornite alla madre, sig.ra Kosovel, informazioni scritte sulla gestione degli episodi e sulle attività sportive consentite (evitare il nuoto non sorvegliato). Su richiesta dei genitori si rilascia certificazione per la scuola ai fini della somministrazione di farmaci in orario scolastico.

Prossimo controllo: 03-09-2024 (con EEG)

Modalità: prenotazione diretta in segreteria

Il Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile

Dott.ssa Marta Kravos

S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Dott.ssa Marta Kravos
Matr. TS-30417

Trieste, 21.05.2024

Documento trasmesso via fax al Pediatra di Libera Scelta su richiesta della famiglia. Contiene dati sanitari riservati.
Se ricevuto per errore distruggerlo e darne comunicazione al mittente.